

TEMA 5.20 • OFTALMOLOGÍA

neurooftalmología 2

PERFIL EUNACOM 6.02.1.026

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Vía Visual: Semiología de los Defectos Campimétricos

El enfrentamiento a los padecimientos neuro-oftalmológicos obliga a identificar inicialmente, mediante con la ayuda topográfica del campo visual, dónde radica la lesión anatómica dentro de las vías nerviosas cerebrales.

- **Concepto Fisiológico Vital de Inversión Óptica Base:** Toda y cualquiera de las imágenes absorbidas en el globo sufre físicamente primero la natural inversión y refracción crasa generada cruzada directamente originada desde el cristalino (Lente base de ocular). Por ende: ¡Las retinas Mediales reciben e interpretan obligadamente el rango lateral del campo externo (Temporal general), mientras en contrario y oposición estricta que las retinas Laterales/Temporales escanean en contrario la base campimétrica interna (Nasal)!

Topografía y Daños en la Vía Visual (Anatomía Clínica)

- **Lesión del Nervio Óptico (Lesión Pre-Quiasmática Directa):** Daña abrumadoramente el conducto único aferente íntegro y total de un solo globo ocular.
- **- Examen de Campo Visual Clínico resultante: Amaurosis Ipsilateral Absoluta** (Ceguera biótica base completa y oscuridad del ojo entero base de ese mismo lado lateral dañado).
- **Lesión en el Quiasma Óptico (Cruce Comisural Medial):** Zona y cruz encrucijada donde exclusivamente se decusan y cambian biológicamente de lado y hemisferio base del cerebro las fibras provenientes de ambas Retinas Mediales oculares (las responsables por ende cruzadas fisiológicamente originadas y receptoras focales generales del Campo Visual Temporal general y lateral).
- **- Examen de Campo Visual Clínico resultante EUNACOM Clásico: Hemianopsia Bitemporal.** (Pierde el paciente la visión externa periférica clásica lateral, es decir tiene "Visión tubular o de túnel central").
- **- Etiología Clásica Endócrina base:** Macroadenomas o severos Tumores puros de la glándula basal originada en la Hipófisis ejerciendo efecto masa y peso comprensivo craso al crecer hacia superior y aplastar la cara inferior del quiasma biótico visual.
- **Lesiones Retro-Quiasmáticas (Cintilla Óptica, Radiaciones o Lóbulo Occipital Base):** El trayecto biótico general post cruce perimetral acopla ya y cursa acarreado integradas definitivamente una mitad completa del mundo exterior (Ej: El hemisferio cortical derecho base humano procesa todo el campo mundo del universo visual izquierdo).
- **- Examen Clásico resultante: Hemianopsia Homónima Contralateral.** (Ej. Si el infarto es en la cintilla base de la cabeza izquierda, el sujeto

por ende pierde por completo las dos mitades derechas y paralelas de su propia vista originadas de las dos retinas homónimas).

- **- Nota Generalizada del término EUNACOM de apoyo al daño biótico base (Congruencia):** Se dice en neurooftalmología que los daños base periféricos mientras más bióticos y exactos se parezcan el borrón entre de las dos mitades enfermas cruzadas oculares, esto base se denomina con mayor **Congruencia Ocular**. Mientras más Congruencia clínica tenga, más distante en el trayecto posterior o occipital general radiacional de decantación final focal del córtex base se hallará la alteración tumoral e isquémica focal causal.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un médico realiza la prueba de la linterna oscilante en un paciente con pérdida visual del ojo izquierdo. Al iluminar el ojo derecho ambas pupilas se contraen. Al pasar la luz al ojo izquierdo, la pupila izquierda se dilata en vez de contraerse. ¿Cuál es el diagnóstico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para neurooftalmología 2. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El reflejo pupilar tiene una vía aferente por el nervio óptico y una vía eferente por el nervio oculomotor hacia el músculo constrictor del iris de ambos ojos.
- El defecto pupilar aferente o signo de Marcus Gunn indica daño del nervio óptico; la pupila se dilata al iluminar el ojo afectado en la prueba de la linterna oscilante.
- El defecto pupilar aferente es el signo más característico de la neuritis óptica y puede verse en neuropatía óptica isquémica, oclusión arterial y desprendimiento de retina.
- El defecto pupilar eferente indica daño del nervio oculomotor; la pupila del ojo afectado no se contrae con ninguna iluminación, produciendo midriasis fija con anisocoría.
- La pupila de Adie es una pupila dilatada de contracción muy lenta por daño del ganglio ciliar, benigna.
- La prueba de la linterna oscilante permite distinguir el defecto aferente del eferente al comparar la respuesta pupilar al iluminar cada ojo alternadamente.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (NEUROFTALMOLOGÍA 2)**PREGUNTA 1**

Un médico realiza la prueba de la linterna oscilante en un paciente con pérdida visual del ojo izquierdo. Al iluminar el ojo derecho ambas pupilas se contraen. Al pasar la luz al ojo izquierdo, la pupila izquierda se dilata en vez de contraerse. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Defecto pupilar eferente del ojo izquierdo por lesión del nervio oculomotor izquierdo
- B)** Defecto pupilar aferente del ojo izquierdo por lesión del nervio óptico izquierdo
- C)** Lesión de la vía eferente bilateral con predominio izquierdo
- D)** Pupila de Adie del ojo izquierdo
- E)** Reflejo pupilar normal asimétrico fisiológico

PREGUNTA 2

Un paciente llega a urgencias con ptosis palpebral derecha, ojo derecho desviado hacia abajo y afuera, y pupila derecha dilatada que no reactiva a la luz. El ojo izquierdo es completamente normal. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Defecto pupilar aferente derecho por neuritis óptica
- B)** Parálisis del nervio oculomotor derecho con defecto pupilar eferente
- C)** Síndrome de Horner derecho
- D)** Parálisis del nervio abducente derecho
- E)** Pupila de Adie derecha con ptosis asociada

PREGUNTA 3

¿Cuál es la diferencia fundamental entre el defecto pupilar aferente y el defecto pupilar eferente al realizar la prueba de la linterna oscilante?

- A)** En el aferente ambas pupilas se contraen; en el eferente ninguna se contrae
- B)** En el aferente la pupila del ojo afectado se dilata al iluminar ese ojo; en el eferente la pupila afectada no se contrae con ninguna iluminación
- C)** Son clínicamente idénticos y no pueden diferenciarse con la prueba de la linterna
- D)** En el aferente hay midriasis bilateral; en el eferente hay midriasis unilateral
- E)** El aferente siempre se asocia a ptosis; el eferente nunca produce ptosis

RESUMEN: NEUROFTALMOLOGÍA 2

Esta clase aborda el reflejo pupilar y sus alteraciones, que son signos neurológicos fundamentales en la evaluación del paciente. El reflejo pupilar normal funciona de la siguiente manera: la luz entra al ojo, estimula la retina, viaja por el nervio óptico como vía aferente hasta el mesencéfalo, y desde allí el estímulo viaja por el nervio oculomotor como vía eferente hacia el músculo constrictor del iris de ambos ojos. Por eso cuando se ilumina un ojo, ambas pupilas se contraen: la ipsilateral de manera directa y la contralateral de manera consensual. El defecto pupilar aferente, también llamado signo de Marcus Gunn o pupila de Marcus Gunn, ocurre cuando el nervio óptico de un lado está dañado. Al iluminar el ojo con el nervio óptico dañado, llega menos señal al mesencéfalo, lo que produce una contracción pupilar menor que cuando se ilumina el ojo sano. Si se hace la prueba de la linterna oscilante, al pasar la luz del ojo sano al dañado, la pupila se dilata aparentemente porque el estímulo disminuye. El defecto pupilar aferente relativo es cuando la lesión no es completa. El defecto pupilar eferente ocurre cuando el nervio oculomotor está dañado. Al iluminar cualquier ojo, la pupila del ojo sano se contrae pero la del lado dañado no se contrae porque el nervio eferente está afectado. Esto produce anisocoria con midriasis del ojo afectado. La pupila de Adie es una pupila dilatada que se contrae muy lentamente ante la luz, por daño del ganglio ciliar.